CADEAU 4 / 5 · DIENSTPAKKET

Het alfabet van het beeld: termen en afkortingen in het verslag

Hyperdens, hyperintens, anechogeen, T1, T2, HU en meer; per modaliteit gerangschikt en in één regel uitgelegd, zodat je je verslag nauwkeurig kunt schrijven.

Inhoud

Hoe gebruik je deze woordenlijst

Hoofdstuk 1 · Algemene termen

Hoofdstuk 2 · Röntgen

Hoofdstuk 3 · CT

Hoofdstuk 4 · MRI

Hoofdstuk 5 · Echo en doppler

Hoofdstuk 6 · Afkortingen

Hoofdstuk 7 · Verslagformuleringen

Hoofdstuk 8 · Vaak verward

Hoofdstuk 9 · Vage formuleringen om te vermijden

Volgende stap

OM TE BEGINNEN

Hoe gebruik je deze woordenlijst

232 termen, afkortingen en verslagformuleringen, elk met een uitleg in één regel en een voorbeeld.

> *Juiste woord, juiste modaliteit: densiteit op CT, signaal op MRI, echogeniciteit op echo. Wie deze drie woorden goed gebruikt, maakt zijn verslag meteen betrouwbaarder.*

MODALITEIT	WOORD VOOR DE HELDERHEID	HELDER · DONKER · GELIJK
Röntgen	Opaciteit / radiolucentie (densiteit)	opaciteit · radiolucentie · —
CT	Densiteit (HU)	hyperdens · hypodens · isodens
MRI	Signaal (intensiteit)	hyperintens · hypo-intens · isointens
Echo	Echogeniciteit	hyperechogeen · hypo-echogeen (anechogeen) · isoechogeen

Vaste volgorde van beschrijven

1. **Wat** — laesie, nodus, massa, collectie, effusie...
2. **Waar** — orgaan, segment, zijde, niveau.
3. **Hoeveel** — grootte (in twee of drie vlakken), aantal.
4. **Hoe** — densiteit / signaal / echogeniciteit, begrenzing, contour, interne structuur, aankleuring.
5. **Vergelijk en vat samen** — verandering ten opzichte van het vorige onderzoek; conclusie en advies.

HOOFDSTUK 1

Algemene termen

Woorden voor beschrijving, lokalisatie en vergelijking die bij elke modaliteit terugkomen.

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
Laesie	Algemene term voor elk gebied dat er anders uitziet dan normaal weefsel; op zichzelf onvoldoende.	*Hypodense laesie van ... mm in de rechter leverkwab.*
Focus	Kleine, begrensde laesie.	*Millimetergrote hyperdense focus.*
Nodus	Ronde, scherp begrensde opaciteit in de long tot 3 cm.	*Solide nodus van 6 mm in de rechter bovenkwab.*
Massa	Opaciteit in de long groter dan 3 cm; in het algemeen spraakgebruik een laesie met volume-effect.	*Massalaesie in het mediastinum.*
Focaal / diffuus	Beperkt tot één gebied / verspreid over het hele orgaan.	*Diffuse hepatosteatose.*
Multifocaal	In meer dan één afzonderlijke focus.	*Multifocale aankleurende laesies.*
Homogeen / heterogeen	Interne structuur met uniforme / gemengde densiteit, signaal of echogeniciteit.	*Heterogeen aankleurende massa.*
Scherp begrensd	Met een scherpe grens gescheiden van het aangrenzende weefsel.	*Scherp begrensde cyste met gladde contour.*
Onscherp begrensd (vaag)	Grens gaat geleidelijk over in het aangrenzende weefsel en is niet scherp te onderscheiden.	*Hypodens gebied met vage begrenzing.*
Gelobde contour	Golvende, hobbelige buitencontour.	*Solide nodus met gelobde contour.*
Gespiculeerde contour	Contour met stralenvormige uitlopers naar buiten; relevant met het oog op maligniteit.	*Massa met gespiculeerde contour.*
Massa-effect	Verdringing of compressie van aangrenzende structuren door een laesie.	*Verstreken sulci door massa-effect.*
Shift	Verplaatsing van een structuur uit haar normale positie.	*Shift van 6 mm van de middenlijnstructuren.*
Extrinsieke compressie	Druk van buitenaf op een structuur.	*Extrinsieke compressie van de ureter.*
Invasie	Uitbreiding van een laesie over de grens in het aangrenzende weefsel.	*Verdenking ingroei in het perirenale vet.*
Verkalking	Calciumafzetting in weefsel; op röntgen en CT zeer dens, op echo met schaduw.	*Nodus met grove verkalking.*
Septatie	Dunne septa in een cysteuze laesie.	*Cysteuze laesie met dunne septa.*
Solide component	Gebied met weefselstructuur, zonder vocht, in een cysteuze laesie.	*Aankleurende solide component.*

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
Cysteus / complex cysteus	Laesie met vocht / vochthoudende laesie met septa, dikke wand of solide deel.	*Complexe cysteuze adnexlaesie.*
Necrose	Niet-aankleurend, avitaal gebied in een laesie.	*Massa met centrale necrose.*
Aankleuring	Toename van densiteit of signaal na contrastmiddel.	*Perifere ringvormige aankleuring.*
Oedeem	Toegenomen vocht in het weefsel.	*Vasogeen oedeem rond de laesie.*
Effusie	Vocht in een lichaamsholte (pleura, pericard, gewricht).	*Bilateraal pleuravocht.*
Collectie	Begrensde, gelokaliseerde vochtophoping (abces, hematoom, biloom enz.).	*Gelokaliseerde collectie in het kleine bekken.*
Vrij vocht / vrij lucht	Niet-begrensd vocht / lucht in de peritoneale holte.	*Vrij vocht in de Morison-pouch.*
Proximaal / distaal	Dicht bij / ver van het centrum of de oorsprong.	*Distale uretersteen.*
Anterieur / posterieur	Voor / achter.	*Anterieure mediastinale massa.*
Mediaal / lateraal	Dicht bij / ver van de middenlijn.	*Lateraal tibiaplateau.*
Superieur / inferieur (craniaal / caudaal)	Boven / onder.	*Onderpool van de nier.*
Ipsilateraal / contralateraal	Zelfde zijde / andere zijde.	*Geen contralaterale hydronefrose.*
Axiaal / coronaal / sagittaal	Horizontale / frontale / zijwaartse doorsnedevlakken.	*Duidelijker op de coronale reconstructies.*
Differentiaaldiagnose	Lijst van mogelijke diagnosen die de bevinding kunnen verklaren.	*Differentiaaldiagnostisch abces en necrotische tumor.*
Incidentele bevinding	Toevallig gevonden bevinding, los van de klinische vraag.	*Incidentele bijniernodus.*
Intervalverandering	Verschil tussen twee onderzoeken.	*Geen intervalverandering ten opzichte van het vorige onderzoek.*
Stabiel / progressie / regressie	Onveranderd / toegenomen / afgenomen.	*Laesiegrootte stabiel.*
Artefact	Beeld dat niet tot de werkelijke anatomie behoort maar door de beeldvorming ontstaat.	*Bewegingsartefacten beperken de beoordeling.*
Partieel-volume-effect	Misleidende densiteit of signaal doordat verschillende weefsels binnen één coupe worden uitgemiddeld.	*Mogelijk door partieel-volume-effect.*

HOOFDSTUK 2

Röntgen

Termen voor densiteit, longpatronen, abdomen en bot op de conventionele röntgenfoto.

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
Opaciteit	Wit gebied op röntgen (houdt meer straling tegen).	*Opaciteit in het rechter onderveld.*
Radiolucentie	Zwart gebied op röntgen (houdt weinig straling tegen).	*Radiolucente sikkel onder het diafragma.*
Radio-opaak	Stof of voorwerp dat op röntgen zichtbaar is en straling tegenhoudt.	*Radio-opaak corpus alienum.*
Densiteit	Mate van stralingsverzwakking op röntgen en CT; wordt bij MRI en echo niet gebruikt.	*Schaduw met wekedelendensiteit.*
Consolidatie	Vulling van de alveoli met vocht, cellen of ander materiaal in plaats van lucht; vaten niet zichtbaar.	*Consolidatie met luchtbronchogram.*
Luchtbronchogram	Zichtbare luchthoudende bronchi in geconsolideerd parenchym.	*Luchtbronchogrammen in de consolidatie.*
Silhouetteken	Verdwijnen van de contour tussen twee structuren met dezelfde densiteit als ze elkaar raken.	*Rechter hartcontour uitgewist (middenkwab).*
Reticulair patroon	Netvormige fijne lineaire opaciteiten; interstitiële betrokkenheid.	*Reticulaire opaciteiten basaal.*
Nodulair patroon	Talrijke kleine nodulaire opaciteiten.	*Diffuus nodulair patroon.*
Miliair patroon	Talrijke, diffuse, gelijke noduli van enkele millimeters.	*Bilateraal miliair patroon.*
Kerley B-lijnen	Korte horizontale lijnen perifeer, loodrecht op de pleura; verdikte interlobulaire septa.	*Kerley B-lijnen basaal.*
Peribronchiale cuffing	Verdikking van en face geziene bronchuswanden.	*Peribronchiale cuffing.*
Vasculaire redistributie (cefalisatie)	Vaten in de bovenvelden duidelijker dan die in de ondervelden.	*Vasculaire redistributie in de bovenvelden.*
Cardiothoracale ratio (CTR)	Verhouding van de grootste hartdiameter tot de grootste inwendige thoraxdiameter op een PA-opname.	*CTR vergroot.*
Afstomping van de sinus phrenicocostalis	Verlies van de scherpe hoek tussen diafragma en thoraxwand.	*Linker sinus phrenicocostalis afgestompt.*
Meniscusteken	Concave bovengrens van pleuravocht die naar lateraal oploopt.	*Opaciteit met meniscusconfiguratie.*

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
Deep sulcus-sign	Diep en scherp aspect van de sinus phrenicocostalis bij een pneumothorax op een liggende opname.	*Deep sulcus-sign rechts.*
Pleuralijn	Dunne lijn van de viscerale pleura bij een pneumothorax.	*Apicale pleuralijn.*
Atelectase	Volumeverlies van een deel van de long doordat het luchtledig wordt.	*Atelectase in de linker onderkwab.*
Volumeverlies	Volumeverlies, zichtbaar aan het aantrekken van fissuur, hilus, diafragma of mediastinum.	*Met tekenen van volumeverlies.*
Caviteit	Luchtruimte met wand in een consolidatie of massa.	*Dikwandige caviteit.*
Vloeistofspiegel	Rechte horizontale grens tussen lucht en vocht op een staande of decubitusopname.	*Multipele vloeistofspiegels.*
Hyperinflatie	Overmatige luchthoudendheid van de longen (afgeplat diafragma, vergrote retrosternale ruimte).	*Tekenen van hyperinflatie.*
Mediastinumverbreding	Mediastinumschaduw breder dan verwacht.	*Bovenste mediastinum oogt breed.*
Pneumoperitoneum	Vrij lucht in de peritoneale holte.	*Vrij lucht onder het diafragma.*
Rigler-sign	Zowel de binnen- als de buitenzijde van de darmwand afgetekend door lucht.	*Rigler-sign positief.*
Valvulae conniventes	Slijmvliesplooien in de dunne darm die van wand tot wand lopen.	*Gedilateerde darmlissen met zichtbare valvulae conniventes.*
Haustra	Plooien in de colonwand die niet over het hele lumen doorlopen.	*Gedilateerd colon met zichtbare haustra.*
Onderbreking van de cortex	Onderbreking van de botcortex; teken van een fractuur.	*Onderbreking van de cortex van de distale radius.*
Dislocatie / angulatie	Verplaatsing van de fractuurdelen / hoek tussen de fragmenten.	*Gedisloceerde fractuur met dorsale angulatie.*
Comminutieve fractuur (meerfragmentfractuur)	Fractuur met meer dan twee fragmenten.	*Comminutieve calcaneusfractuur.*
Avulsiefractuur	Klein botfragment dat bij de aanhechting van een pees of band is afgescheurd.	*Avulsiefragment van de laterale tibia.*
Periostreactie	Nieuwe botvorming rond het bot.	*Lamellaire periostreactie.*
Lytische / sclerotische laesie	Botdestructie (radiolucent) / toename van de botdichtheid.	*Multipele lytische laesies.*
Osteopenie	Algehele afname van de botdichtheid.	*Periarticulaire osteopenie.*
Subchondrale sclerose	Toegenomen botdichtheid onder het gewrichtsvlak.	*Subchondrale sclerose en osteofyten.*
Osteofyt	Benige uitsteeksel aan de gewrichtsrand.	*Marginale osteofyten.*
Lipohemartros	Vet-vloeistofspiegel in het gewricht; teken van een intra-articulaire fractuur.	*Suprapatellaire lipohemartros.*

HOOFDSTUK 3

CT

Termen voor HU, vensters, contrastfasen, long- en neuro-CT.

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
HU (Hounsfield-eenheid)	Eenheid van densiteit op CT; water 0, lucht ongeveer −1000, vet negatieve waarden.	*Gemiddelde densiteit van de laesie 12 HU.*
Hyperdens	Witter dan het omliggende weefsel op CT (hoge HU).	*Hyperdense collectie, passend bij de acute fase.*
Hypodens	Donkerder dan het omliggende weefsel op CT (lage HU).	*Hypodense leverlaesie.*
Isodens	Dezelfde densiteit als het omliggende weefsel op CT.	*Subduraal, isodens aan het hersenparenchym.*
Vensterbreedte (W) / vensterniveau (L)	Weergegeven HU-bereik / het midden van dat bereik.	*Beoordeeld in het CVA-venster (smalle W).*
Longvenster	Breed venster voor parenchym, luchtwegen, noduli en pneumothorax.	*Matglasgebieden in het longvenster.*
Mediastinumvenster (weke delen)	Voor vaten, lymfeklieren, organen en vocht.	*Lymfeklieren in het mediastinumvenster.*
Botvenster	Zeer breed venster voor cortex en trabeculaire structuur.	*Fractuurlijn in het botvenster.*
CVA-venster	Smal hersenvenster dat het verschil tussen grijze en witte stof vergroot.	*Verlies van het insulair lint in het CVA-venster.*
Subduraal venster	Venster van gemiddelde breedte voor dunne collecties tegen de schedel.	*Dunne collectie in het subdurale venster.*
Blanco fase	Coupes vóór jodiumhoudend contrast (bloeding, steen, verkalking).	*Hyperdens op de blanco coupes.*
Arteriële fase	Vroege fase waarin de arteriën het sterkst aankleuren.	*Laesie met sterke aankleuring in de arteriële fase.*
Portaal-veneuze fase	Standaardfase voor het abdomen, waarin de v. portae en de systemische venen gevuld zijn.	*Beoordeeld in de portaal-veneuze fase.*
Late (excretie)fase	Late fase waarin het contrast naar het verzamelsysteem en de blaas gaat.	*Contrastlekkage in de late fase.*
Washout (uitwassing)	Een laesie die in de arteriële fase aankleurt en in latere fasen donkerder wordt dan de omgeving.	*Washout in de portaal-veneuze fase.*
Actieve extravasatie	Contrast dat buiten het vat treedt en tussen de fasen toeneemt; actieve bloeding.	*Actieve extravasatie rond de milt.*
Vullingsdefect	Gebied zonder contrast in een met contrast gevuld lumen (trombus, tumor).	*Vullingsdefect in een segmentale arterie.*

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
Intimaflap	Dunne membraan die bij een dissectie het ware en het valse lumen scheidt.	*Intimaflap in de aorta ascendens.*
MPR	Multiplanaire reconstructie (coronaal, sagittaal, schuin).	*Wervelfractuur op sagittale MPR.*
MIP	Maximum intensity projection; voor vaten en noduli.	*Nodus duidelijk op de MIP-beelden.*
VR (3D-volume)	Driedimensionale volumeweergave.	*Fractuurconfiguratie op de 3D-beelden.*
Coupedikte	Dikte van het gereconstrueerde beeld; dunne coupes tonen kleine laesies.	*Beoordeeld op coupes van 1 mm.*
Beam hardening-artefact	Donkere banden tussen dicht bot of contrast.	*Beam hardening-artefact in de fossa posterior.*
Metaal(streep)artefact	Heldere en donkere strepen die vanuit een metalen implantaat uitstralen.	*Metaalartefact rond de prothese.*
Matglasopaciteit	Lichte densiteitstoename die vaat- en bronchuswanden niet uitwist.	*Perifere matglasopaciteiten.*
Crazy paving	Septale verdikking bovenop matglas.	*Crazy paving-patroon.*
Tree-in-bud	Centrilobulaire, vertakkende kleine noduli; aandoening van de kleine luchtwegen.	*Tree-in-bud in de rechter onderkwab.*
Honeycombing	Rijen subpleurale cysteuze luchtruimten met een wand; fibrose.	*Basaal subpleuraal honeycombing.*
Mozaïekattenuatie	Verschillende densiteit tussen aangrenzende gebieden (air trapping of perfusieverschil).	*Mozaïekattenuatiepatroon.*
Bronchiëctasie	Blijvende verwijding van een bronchus (bronchus breder dan de begeleidende arterie).	*Cilindrische bronchiëctasieën in de onderkwabben.*
Emfyseem	Destructie van parenchym met wandloze luchtruimten (centrilobulair, paraseptaal, panlobulair).	*Centrilobulair emfyseem in de bovenkwabben.*
Extra-axiaal / intra-axiaal	Buiten het hersenparenchym (dura, arachnoidea) / erin.	*Extra-axiaal gelegen massa.*
Midline shift	Verschuiving van het septum pellucidum of de falx ten opzichte van de middenlijn.	*Middenlijnverschuiving van 7 mm naar links.*
Herniatie (hersenen)	Verplaatsing van hersenweefsel van het ene compartiment naar het andere (subfalcine, uncale, tonsillaire).	*Subfalcine herniatie.*
Hyperdens-arteriesign	Hyperdens aspect van een getromboseerde arterie op blanco CT.	*Hyperdens-arteriesign in de rechter ACM.*
Grijze-wittestofdifferentiatie	Densiteitsverschil tussen cortex en witte stof; verlies ervan is een vroeg teken van ischemie.	*Grijze-wittestofdifferentiatie verdwenen.*
Vetinfiltratie	Lineaire densiteitstoename in vetweefsel door ontsteking.	*Vetinfiltratie rond de appendix.*
Pneumatosis	Gas in de darmwand.	*Pneumatosis van de dunnedarmwand.*

HOOFDSTUK 4

MRI

Sequenties, signaaltermen, aankleuringspatronen en artefacten.

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
T1-gewogen (T1W)	Vet helder, vocht donker; anatomie en beoordeling voor/na contrast.	*Hyperintense focus op T1W.*
T2-gewogen (T2W)	Vocht helder; toont oedeem en pathologie.	*Hyperintense laesie op T2W.*
FLAIR	T2 met onderdrukt liquorsignaal; voor periventriculaire laesies en sulcale pathologie.	*Periventriculaire hyperintensiteiten op FLAIR.*
PD (protondensiteit)	Bij musculoskeletale MRI voor meniscus en kraakbeen; vaak met vetsuppressie.	*Signaaltoename op de PD-serie met vetsuppressie.*
STIR	Vochtgevoelige sequentie met vetsuppressie; voor beenmergoedeem.	*Beenmergoedeem op STIR.*
Vetsuppressie	Techniek die het vetsignaal onderdrukt.	*Signaalverlies op de series met vetsuppressie (bevat vet).*
DWI (diffusiegewogen beeldvorming)	Toont de beweging van watermoleculen; acute ischemie, abces, hypercellulaire laesie.	*Hyperintens gebied op DWI.*
ADC-map	Kwantitatieve diffusiemap; donker bij restrictie.	*Laag signaal op de ADC.*
Diffusierestrictie	Helder op DWI + donker op ADC.	*Uitgesproken diffusierestrictie.*
T2-shine-through	Helder aspect op DWI door de T2-helderheid; ook helder op de ADC, dus geen echte restrictie.	*Passend bij T2-shine-through.*
SWI / GRE (T2*)	Sequenties die gevoelig zijn voor bloedproducten, calcium en ijzer.	*Microbloedingen op SWI.*
Blooming	Uitvergroot signaalverlies rond bloedproducten of metaal op SWI/GRE.	*Focus met blooming op GRE.*
Hyperintens	Helderder signaal dan de omgeving op MRI.	*Hyperintens op T2W.*
Hypo-intens	Donkerder signaal dan de omgeving op MRI.	*Hypo-intens op T1W.*
Isointens	Hetzelfde signaal als de omgeving op MRI.	*Isointens aan grijze stof.*
Signaalverlies	Afwezigheid van verwacht signaal (flow, metaal, lucht, calcium).	*Signaalverlies in de out-of-phase.*
Flow void	Snel stromend bloed dat zwart is op T2.	*Flow void in de a. basilaris behouden.*
Gadoliniumaankleuring	Signaaltoename op T1 na MRI-contrast.	*Homogeen aankleurende massa.*
Dynamische contrastserie	Timing van de aankleuring met series die na contrast snel achter elkaar worden gemaakt.	*Laat aankleurende focus op de dynamische series.*
TOF-MR-angiografie	Arteriële MR-angiografie zonder contrast.	*Occlusie van M1 op TOF-MRA.*

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
MR-venografie	Voor de durale veneuze sinussen en venen.	*Vullingsdefect in de sinus transversus op MRV.*
MRCP	Sterk T2-gewogen techniek die de gal- en pancreasgangen in beeld brengt.	*Vullingsdefect in de ductus choledochus op MRCP.*
Chemical shift (in-phase / out-of-phase)	Toont intracellulair vet; signaalverlies in de out-of-phase.	*Signaalverlies in de out-of-phase (adenoom).*
Perfusie-MRI	Toont de weefseldoorbloeding (tumorgraad, CVA).	*Verhoogd rCBV.*
Dural tail	Aankleurende verdikking die van de massa naar de dura loopt.	*Dural tail-sign.*
Leptomeningeale aankleuring	Aankleuring die het hersenoppervlak en de sulci volgt (infectie, tumorspreiding).	*Leptomeningeale aankleuring langs de sulci.*
Pachymeningeale aankleuring	Gladde aankleuring langs de dura.	*Diffuse pachymeningeale aankleuring.*
Vasogeen / cytotoxisch oedeem	In de witte stof, vingervormig, door vaatpermeabiliteit / intracellulair, met diffusierestrictie op DWI (ischemie).	*Vasogeen oedeem rond de laesie.*
Beenmergoedeem	Helderheid van het beenmerg op STIR of op T2 met vetsuppressie.	*Beenmergoedeem in de laterale femurcondyl.*
Sequentie	MRI-beeldserie die met bepaalde parameters is verkregen.	*Aanvullende sequenties geadviseerd.*
TR / TE	Repetitietijd / echotijd; bepalen de weging.	*Artefact in series met korte TE.*
Magic angle-artefact	Schijnbare signaaltoename in series met korte TE in een pees die ongeveer 55° ten opzichte van het magneetveld staat.	*Mogelijk passend bij een magic angle-artefact.*
Susceptibiliteitsartefact	Signaalverlies en vervorming aan de grens met metaal of lucht.	*Susceptibiliteitsartefact door een metalen implantaat.*
Stadium van bloeding (MRI)	Het T1- en T2-signaal van bloed verandert in de tijd; details in de tabel aan het eind van dit hoofdstuk.	*Hematoom, passend bij het laat-subacute stadium.*

Stadia van bloeding: MRI-signaal (hersenen)

STADIUM	T1	T2
Hyperacuut	iso / licht hypo	hyper
Acuut	iso / hypo	hypo
Vroeg subacuut	hyper	hypo
Laat subacuut	hyper	hyper
Chronisch	hypo	hypo (hemosiderinerand)

Let op

Deze tabel is het klassieke onderwijsschema; het werkelijke beeld kan variëren met de veldsterkte, de grootte van het hematoom en de sequentie. Stel de leeftijd van een bloeding niet uitsluitend op basis van deze tabel vast.

HOOFDSTUK 5

Echo en doppler

Termen voor echogeniciteit, artefacten, probes, doppler en longecho.

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
Echogeniciteit	Hoeveelheid echo die weefsel op echo terugkaatst; de woorden densiteit of signaal worden niet gebruikt.	*Verhoogde echogeniciteit van het parenchym.*
Anechogeen	Geeft helemaal geen echo's (zwart); simpel vocht.	*Anechogene cysteuze laesie.*
Hypo-echogeen	Minder echo's dan de omgeving (donkerder).	*Hypo-echogene solide nodus.*
Isoechogeen	Dezelfde echogeniciteit als de omgeving.	*Laesie isoechogeen aan het parenchym.*
Hyperechogeen	Meer echo's dan de omgeving (helderder).	*Hyperechogene focus.*
Echogene inhoud (debris)	Echogevende deeltjes in vocht (bloed, pus, eiwit).	*Collectie met interne echogene inhoud.*
Posterieure akoestische schaduw	Zwart gebied achter een structuur waar geluid niet doorheen gaat (steen, verkalking).	*Hyperechogene focus met akoestische schaduw.*
Posterieure akoestische versterking	Helderder gebied achter vocht.	*Cyste met posterieure akoestische versterking.*
Dirty shadowing	Heterogene, grijze schaduw achter gas.	*Gashaarden met dirty shadowing.*
Reverberatie	Herhaalde parallelle lijnen tussen twee reflecterende oppervlakken.	*Reverberatieartefact.*
Komeetstaartartefact	Korte staart achter een kleine heldere focus (cholesterolkristal, adenomyomatose).	*Komeetstaartartefacten in de wand.*
Spiegelbeeldartefact	Kopie van een structuur voorbij een sterk reflecterend oppervlak (diafragma).	*Spiegelbeeldartefact boven het diafragma.*
Twinkling-artefact	Kleurenmozaïek achter een steen met ruw oppervlak op kleurendoppler.	*Steen met twinkling-artefact.*
Gain	Instelling van de beeldhelderheid; een verkeerde instelling geeft een verkeerde inschatting van de echogeniciteit.	*Beoordeeld met een passende gaininstelling.*
Lineaire probe	Hoge frequentie, oppervlakkige structuren (schildklier, mamma, vaten, pleura).	*Beoordeeld met een lineaire probe.*
Convexe probe	Lage frequentie, diepe abdominale structuren.	*Scan van het abdomen met een convexe probe.*
Sector-(phased-array-)probe	Klein contactoppervlak; hart en intercostale vensters.	*Subxifoïdale sectorprobe.*

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
B-mode / M-mode	Grijswaardenbeeld / beweging in de tijd langs één lijn.	*Verlies van pleurasliding in M-mode.*
Kleurendoppler	Toont richting en aanwezigheid van flow met kleur.	*Geen flow op kleurendoppler.*
Power doppler	Richtingsonafhankelijke doppler, gevoeliger voor trage flow.	*Toegenomen vascularisatie op power doppler.*
Spectrale doppler	Golfvorm van de stroomsnelheid in de tijd.	*Monofasische flow bij spectrale analyse.*
PSV	Piek-systolische snelheid.	*PSV verhoogd.*
Resistiviteitsindex (RI)	Ratio die de weerstand van het vaatbed weergeeft.	*Intrarenale RI-waarden.*
Aliasing	Kleuromslag wanneer de stroomsnelheid de meetgrens overschrijdt.	*Stenotisch segment met aliasing.*
Respiratoire fasiciteit	Variatie van de veneuze flow met de ademhaling; verlies wijst op proximale obstructie.	*Fasiciteit in de v. femoralis communis behouden.*
Augmentatie	Toename van de veneuze flow bij distale compressie.	*Augmentatierespons aanwezig.*
Compressie (comprimeerbaarheid)	Volledig dichtdrukken van de vene met de probe; niet dichtdrukken is een DVT-criterium.	*V. poplitea volledig comprimeerbaar.*
Sonografische Murphy	Maximale drukpijn bij drukken met de probe op de galblaas.	*Sonografische Murphy positief.*
Pleurasliding	Heen-en-weerbeweging van de pleuralijn met de ademhaling; de aanwezigheid ervan sluit op dat punt een pneumothorax uit.	*Bilateraal pleurasliding aanwezig.*
A-lijn	Horizontale, zich op gelijke afstand herhalende lijnen onder de pleuralijn.	*A-patroon.*
B-lijn	Verticaal artefact dat van de pleura tot onderaan het scherm loopt en de A-lijnen uitwist.	*B-patroon.*
Lung point	Punt waar glijdende en niet-glijdende pleura elkaar raken; specifiek voor pneumothorax.	*Lung point aangetoond.*
Hepatisatie	Leverachtig weefselaspect van geconsolideerde long.	*Hepatisatie en luchtbronchogrammen.*
Sludge	Gelaagde echogene inhoud zonder schaduw in de galblaas.	*Sludge in de galblaas.*
WES-teken	Wand–echo–schaduw-trias bij een galblaas vol stenen.	*WES-teken aanwezig.*

HOOFDSTUK 6

Afkortingen

De afkortingen die je het vaakst tegenkomt in verslagen en tijdens diensten.

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
PA / AP	Posteroanterieure / anteroposterieure projectie.	*Bedside AP-opname.*
CTR	Cardiothoracale ratio.	*CTR > 0,5.*
ETT	Endotracheale tube.	*Tip van de ETT 4 cm boven de carina.*
NMS	Neusmaagsonde.	*Tip van de NMS in de maag.*
CVC	Centraal veneuze katheter.	*Tip van de CVC in de distale VCS.*
CT / CTA	Computertomografie / CT-angiografie.	*CTA geadviseerd.*
MRI / MRA / MRV	Magnetische resonantie / MR-angiografie / MR-venografie.	*Beoordeling met MRV geadviseerd.*
MRCP	MR-cholangiopancreaticografie.	*MRCP geadviseerd.*
Echo	Echografie.	*Controle-echo geadviseerd.*
POCUS	Bedside echografie (point-of-care).	*Geen pericardvocht bij POCUS.*
FAST / eFAST	Gerichte echo bij trauma / uitgebreide FAST die ook long en pleura omvat.	*eFAST negatief.*
DWI / ADC	Diffusiegewogen beeldvorming / apparent diffusion coefficient.	*Diffusierestrictie, overeenkomend op DWI/ADC.*
FLAIR / STIR / SWI / PD	Namen van MRI-sequenties (zie het hoofdstuk MRI).	*Oedeem op STIR.*
HU	Hounsfield-eenheid.	*Gemiddeld 8 HU.*
ROI	Interessegebied waarin wordt gemeten.	*Densiteitsmeting met een ROI.*
MPR / MIP / VR	Multiplanaire reconstructie / maximum intensity projection / volume rendering.	*Coronale MPR.*
SAB	Subarachnoïdale bloeding.	*SAB in de basale cisternen.*
SDH / EDH	Subduraal / epiduraal hematoom.	*Acuut SDH.*
ICB	Intracerebrale bloeding.	*ICB in de rechter basale kernen.*
DVT	Diepe veneuze trombose.	*Acute DVT.*
LE / PE	Longembolie / pulmonale trombo-embolie.	*Segmentale LE.*
AAA	Aneurysma van de abdominale aorta.	*Infrarenaal AAA.*
VCS / VCI	Vena cava superior / vena cava inferior.	*Contrastreflux naar de VCI.*
AMS / VMS	A. / v. mesenterica superior.	*AMS doorgankelijk.*

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
ACI / ACM / ACA / ACP	A. carotis interna / a. cerebri media, anterior, posterior.	*Occlusie van M1 van de linker ACM.*
RV / LV	Rechter / linker ventrikel.	*RV/LV-ratio verhoogd.*
VKB / AKB	Voorste kruisband / achterste kruisband.	*Volledige ruptuur van de VKB.*
MCL / LCL	Mediale / laterale collaterale band.	*MCL-letsel graad 1.*
UPJ / UVJ	Pyelo-ureterale / ureterovesicale overgang.	*UVJ-steen.*
CPH	Cerebellopontiene hoek (brughoek).	*Massa in de linker CPH.*
EMV	Glasgow Coma Scale (EMV-score).	*EMV 13.*
ASPECTS	Scoresysteem voor vroege ischemie in het stroomgebied van de ACM.	*ASPECTS 8.*
PSV / RI	Piek-systolische snelheid / resistiviteitsindex.	*PSV verhoogd.*
PLAPS	Posterolateraal alveolair en/of pleuraal syndroompunt bij longecho.	*PLAPS rechts positief.*
BI-RADS / TI-RADS / LI-RADS	Verslag- en classificatiesystemen voor mamma / schildklier / lever.	*TI-RADS-categorie …*

HOOFDSTUK 7

Verslagformuleringen

Formuleringen die mate van zekerheid, vergelijking en advies correct uitdrukken.

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
Passend bij ...	Hoge zekerheid; de bevinding ondersteunt sterk één enkele diagnose.	*Passend bij acute appendicitis.*
Pleit voor ... / in eerste instantie wordt gedacht aan ...	Matig tot hoge zekerheid; meest waarschijnlijke diagnose.	*In eerste instantie wordt aan een abces gedacht.*
... kan relevant zijn met het oog op ...	Matige zekerheid; de bevinding ondersteunt de diagnose maar is niet specifiek.	*In samenhang met de kliniek mogelijk relevant met het oog op infectie.*
Differentiaaldiagnostisch moet aan ... worden gedacht	Meer dan één mogelijkheid; noem ze in volgorde.	*Differentiaaldiagnostisch moet aan metastase en abces worden gedacht.*
... kan niet worden uitgesloten	Lage waarschijnlijkheid maar belangrijk; gebruik zo nodig samen met een advies.	*Vroege ischemie kan niet worden uitgesloten; MRI geadviseerd.*
Geen ... / ... niet aangetoond	Afwezigheid van de gezochte bevinding (negatieve bevinding).	*Geen vrij lucht.*
Op de beoordeelde coupes	Geeft aan dat de negatieve bevinding alleen het afgebeelde gebied betreft.	*Op de beoordeelde coupes geen acute pathologie.*
Vergeleken met het vorige onderzoek (datum)	Geeft aan dat er vergeleken is en met welke referentie.	*Toegenomen grootte vergeleken met ....*
Geen evidente verandering	Stabiele bevinding.	*Geen evidente verandering in de grootte van de nodus.*
Beoordeling in samenhang met klinische en laboratoriumbevindingen geadviseerd	Situatie die beeldvorming alleen niet kan onderscheiden; schrijf op met wat er gecorreleerd moet worden.	*Beoordeling in samenhang met CRP en kweek geadviseerd.*
Aanvullende beeldvorming met ... geadviseerd	Advies voor een specifiek onderzoek, met de reden.	*MRI met contrast geadviseerd voor karakterisering.*
Controle na ... geadviseerd	Follow-up; noteer het interval volgens het advies van je instelling of de betreffende richtlijn.	*Controle-CT met een interval volgens de richtlijn geadviseerd.*
Technische beperking: ...	Benoemt de factor die de beoordeling beperkt.	*Beperkte beoordeling door bewegingsartefacten.*
Bevinding om ... uur telefonisch doorgegeven aan ...	Registratie van de melding van een kritieke bevinding.	*Om 03:40 uur doorgegeven aan de SEH-arts.*

TERM	UITLEG IN ÉÉN REGEL	VOORBEELD
Conclusie:	Kort, helder antwoord op de klinische vraag aan het eind van het verslag.	*Conclusie: Acute longembolie; geen tekenen van rechterhartbelasting.*

HOOFDSTUK 8

Vaak verward

Termenparen die op elkaar lijken maar iets anders betekenen.

TERMEN	VERSCHIL	IN DE PRAKTIJK
Hyperdens · hyperintens · hyperechogeen	Alle drie betekenen «helderder», maar ze horen bij een modaliteit: hyperdens = CT (en densiteit op röntgen), hyperintens = MRI, hyperechogeen = echo.	Schrijf op CT geen «hyperintens» en op MRI geen «hyperdens».
Opaciteit · densiteit	Opaciteit is de naam van een gebied dat op röntgen wit is; densiteit is de mate van stralingsverzwakking (röntgen en CT).	Niet «toegenomen opaciteit», maar «opaciteit» of «toegenomen densiteit».
Hypodens · hypo-intens · hypo-echogeen	Donker aspect: CT / MRI / echo.	Bij een leverecho schrijf je geen «hypodense laesie».
Radiolucent · radio-opaak	Zwart (straling gaat erdoor) / wit (straling wordt tegengehouden) op röntgen.	Radio-opake steen, radiolucente lucht.
Anechogeen · hypo-echogeen	Anechogeen: helemaal geen echo's (simpel vocht); hypo-echogeen: weinig echo's (kan weefsel zijn).	Noem een hypo-echogene laesie geen «cyste».
Cyste · cysteus	Een cyste is een vochtholte met een wand; cysteus beschrijft alleen een vochtachtig aspect.	Laesie met cysteus aspect ≠ simpele cyste.
Nodus · massa	In de long onderscheiden op grootte (grens 3 cm); in het algemeen op grootte en volume-effect.	Noem een laesie van 4 cm geen «nodus».
Consolidatie · matglas	Bij consolidatie zijn de vaten niet zichtbaar; bij matglas wel.	Zijn de vaten zichtbaar, dan is het matglas.
Consolidatie · atelectase	Bij atelectase is er volumeverlies; bij consolidatie niet.	Is de fissuur aangetrokken, dan is het atelectase.
Effusie · collectie · ascites	Effusie: vocht in een lichaamsholte; collectie: gelokaliseerd vocht; ascites: vrij vocht in de peritoneale holte.	Voor gelokaliseerd vocht «collectie», niet «effusie».
Aankleuring · hyperdensiteit	Aankleuring is een toename na contrast; hyperdensiteit kan ook zonder contrast bestaan (bloed, calcium).	Zeg niet «kleurt aan» zonder te vergelijken met de blanco coupes.
Diffusierestrictie · T2-shine-through	Bij restrictie is de ADC donker; bij T2-shine-through is ook de ADC helder.	Beslis niet op basis van de DWI zonder naar de ADC te kijken.
Vasogeen · cytotoxisch oedeem	Vasogeen: in de witte stof, rond een tumor; cytotoxisch: grijze en witte stof, ischemie, restrictie op DWI.	Oedeem rond een tumor is vasogeen.
Epiduraal · subduraal	Epiduraal: biconvex, kruist de suturen niet; subduraal: sikkelvormig, kruist de suturen wel.	Beschrijf de vorm, benoem daarna.

TERMEN	VERSCHIL	IN DE PRAKTIJK
Intra-axiaal · extra-axiaal	In het parenchym / buiten het parenchym (dura, arachnoidea).	Een meningeoom is extra-axiaal.
Protrusie · extrusie	Bij een protrusie is de basis breed; bij een extrusie is de hals smal of is er fragmentmigratie.	Bij craniale migratie is het een extrusie.
Akoestische schaduw · akoestische versterking	Schaduw: zwart achter steen/calcium; versterking: helder achter vocht.	Een cyste geeft versterking, een steen schaduw.

HOOFDSTUK 9

Vage formuleringen om te vermijden

Formuleringen die de beslissing van de lezende arts bemoeilijken, en wat je in plaats daarvan schrijft.

VERMIJD	WAAROM	IN PLAATS DAARVAN
«Infiltraat»	Zegt niet om welk patroon het gaat.	Consolidatie, matglas, reticulaire of nodulaire opaciteit.
«Geen pathologie»	Onduidelijk wat er beoordeeld is en wat de beperkingen zijn.	«Op de beoordeelde coupes geen acute pathologie.»
«Correleren met de kliniek» (zonder meer)	Er staat niet bij met welke klinische gegevens vergeleken moet worden.	«Beoordeling in samenhang met CRP en lichamelijk onderzoek geadviseerd met het oog op ....»
«Verdacht aspect»	Onduidelijk waarvan het een verdenking is.	«Verdacht voor ...; differentiaaldiagnostisch ...»
«Massa?» (vraagteken)	Een vraagteken in het verslag maakt de mate van zekerheid onduidelijk.	Passende formulering van zekerheid: «pleit voor ...», «... kan niet worden uitgesloten».
«Licht / uitgesproken» (zonder maat)	Verschilt per lezer en is bij follow-up niet te vergelijken.	Geef een maat: «... mm», «midline shift 5 mm».
«Laesie» (zonder meer)	Zegt niets zonder densiteit/signaal, grootte, begrenzing en lokalisatie.	«Scherp begrensde hypodense laesie van 14 mm in segment 7 van de rechter leverkwab.»
«Tumor»	Zonder weefseldiagnose is het een histologisch oordeel.	«Massa» of «massalaesie»; met differentiaaldiagnose.
«Densiteit» op MRI, «opaciteit» op echo	Term die niet bij de modaliteit hoort.	Op MRI «signaal», op echo «echogeniciteit».
«Binnen normale grenzen» (voor alles)	Het blijft onduidelijk wat er beoordeeld is.	Beschrijf de betreffende organen een voor een, kort.
«Waarschijnlijk artefact»	De lezer weet niet of hij de bevinding moet meewegen.	Benoem het type artefact en adviseer zo nodig een herhalingsopname.

Gouden regel

Elke zin moet deze vraag beantwoorden: wat doet de lezende arts met deze zin? Is het antwoord onduidelijk, maak de zin dan concreet met een maat, een mate van zekerheid of een advies.

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

Volgende stap

Open nu Cadeau 5 · Oefenboek: van bevinding tot verslag. De termen en verslagformuleringen uit deze woordenlijst ga je zelf gebruiken in de oefeningen en in de verslagsjablonen per modaliteit.

Om de termen bij echte bevindingen te zien, kun je teruggaan naar **Cadeau 1 · Atlas van de meest voorkomende bevindingen**.